

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	女性壓力性尿失禁 Stress Urinary Incontinence in Women				
	編號	制定者	核准者	公布日期	102 年 02 月 25 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 2.0 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解女性壓力性尿失禁的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施以及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

不同類型的尿失禁中，以壓力性尿失禁(Stress Urinary Incontinence, SUI)最為常見，其次為混合型尿失禁及急迫性尿失禁。國際尿失禁協會對SUI定義為「逼尿肌在沒有收縮情況下，當腹壓突然增加（如咳嗽、用力）所導致尿液不自主的滲漏」。

（二）症狀

1. 常見症狀是站立時會感到陰道口像有東西塞住一樣，且有時會有頻尿或滲尿現象。
2. 自覺頻尿、尿急感、尿急而漏尿、尿床等。
3. 嚴重時有可能出現下腹部下墜不適感及背痛、膀胱排空困難而易引起膀胱感染發炎。

（三）常見檢查

1. 實驗室常規檢查：尿液分析、尿液培養、肝腎功能、電解質。
2. 尿動力學檢查：包括膀胱功能的測定和尿道功能的測定。藉由尿動力學分析儀

主題名稱	女性壓力性尿失禁	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M09	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/10

(即尿動力學檢查機)，測量膀胱與尿道壓力的變化，以及括約肌收縮的情形。

- 3.陰道超音波：用特殊探頭，置入陰道中，直接檢查子宮、卵巢及附屬器官。
- 4.膀胱鏡檢查：利用一條直徑約 2 公分的金屬管，經由尿道放入膀胱，可以瞭解膀胱內部是否有異常的情形。
- 5.膀胱尿道排尿攝影：將顯影劑注入膀胱，先拍攝膀胱正面及斜位影相，然後請受檢者排尿，在透視 X 光監視之下，察看尿道的情況及膀胱輸尿管之間是否有迴流，並將它攝影成相，可檢查出膀胱、輸尿管逆流或腎臟內逆流的情形，其他如膀胱的容量、功能及餘尿量、尿道的異常。

(四) 常見治療

1. 保守療法

- (1) 藥物治療：使用 α -腎上腺素藥物、女性賀爾蒙、三環抗憂鬱劑如 Imipramine 可增加膀胱容量和尿道封閉壓，改善尿失禁的症狀。
- (2) 骨盆底肌肉運動(Pelvic floor muscle exercise, PFME)又稱凱格爾氏運動(Kegel exercise)：常用來治療骨盆底肌肉功能不良所引起的尿失禁，為最優先首選的治療處置，其改善率可高達 80%以上。骨盆底肌肉訓練是一種物理治療，藉由病人主動式的收縮和放鬆運動，以訓練尿道周圍和強化骨盆底肌肉群強度和耐力，而達到尿道阻力和加強尿道括約肌的力量，以改善不自主尿液滲漏。其方法為首先讓病人瞭解「恥-尾骨」肌肉群的位置，可以讓女性病人以一隻手指放入陰道內，並感覺它的收縮，另一隻手放在腹部，注意到腹部肌肉應該保持放鬆；強調「正確」的收縮比「有力」的收縮更重要。放鬆大腿、臀、腹部之肌肉，想像要忍住解大便而夾緊肛門周圍之肌肉，每天做 3 次，每次做 10 次的收縮，且每次收縮可以訓練到 10 秒鐘；或是每次排空膀胱解小便時，中間試著忍住暫停，等數秒再解完。
- (3) 生物回饋法：以生物回饋儀協助骨盆底肌肉訓練，透過電子或機械的儀器傳達神經肌肉、膀胱活動，特別是骨盆底肌肉運動的訊息。
- (4) 電刺激療法：輔助性的被動訓練法，分為陰道及肛門電刺激兩種方式，以

主題名稱	女性壓力性尿失禁	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M09	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/10

直流電刺激無法自行正確收縮骨盆底肌肉婦女的陰道及尿道附近肌肉，增加肌肉的控制能力、強化尿道閉鎖之機制與抑制膀胱的過度活動。電流每刺激 5 秒，休息 10 秒，持續 15 分鐘。

2. 手術治療

手術最主要的目的是恢復尿道的阻力，手術種類如下：

- (1) 膀胱頸懸吊術：目前效果最好，目的在使膀胱頸及尿道經懸吊而維持正常的位置。手術包括腹式恥骨後懸吊術如Burch手術及MMK手術，前者的副作用較少，為腹式手術的經典；陰道式懸吊術，由陰道前壁切開，將膀胱頸或尿道旁組織懸吊固定於腹直肌的筋膜；腹腔鏡膀胱頸懸吊術，腹腔鏡手術的成功率仍不如傳統的陰道懸吊術好；陰道旁修補術原先用來治療膀胱膨出，也可用來治療某些尿失禁。
- (2) 吊帶手術：可採用自體組織，如腹直肌肌膜或大腿側肌膜的筋膜做吊帶的材料，用來支撐尿道中段，此外也可用人工合成的材料作吊帶。手術包括前陰道壁吊帶(AVWS)術利用自體的陰道組織就地作為吊帶，不須額外另開傷口來取組織；無張力性陰道吊帶(TVT／TVT-O)手術來治療尿失禁，可在局部、半身或全身麻醉下進行，長期治癒率應有九成以上。
- (3) 尿道充填注射：尿道下膠原蛋白(Contigen)注射，可在門診治療，適用於年老或手術風險高的病人。在局部麻醉下，藉尿道鏡或超音波導引，施行尿道黏膜下注射，增加尿道的閉鎖機能。注入的膠原蛋白經過一段時間後有可能會被組織吸收，所以必要的時候還要追加注射。尿道下注射自體脂肪的效果較差，近來則有注射矽膠顆粒懸浮液(Durasphere)的治療報告。
- (4) 人工括約肌置入術：最後的治療方案，在女性病人比較少用。

(五) 護理問題

1. 尿失禁／與骨盆底鬆弛有關。
2. 社交互動困難／與尿失禁引起羞恥及缺乏自信心有關。
3. 焦慮感受／與手術前後相關知識不足及不確定感有關。

主題名稱	女性壓力性尿失禁	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M09	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	4/10

4. 疼痛不適／與手術後傷口有關。

5. 易感染／與手術後傷口有關。

(六) 護理措施

1. 尿失禁／與骨盆底鬆弛有關

(1) 評估病人壓力性尿失禁嚴重程度及主要原因。

(2) 向病人說明壓力性尿失禁治療方向和過程。

(3) 教導病人紀錄排尿日記、夜間解尿時間及次數、滲尿量和次數、棉墊使用量與喝水量等逐一記錄。

(4) 教導病人骨盆底肌肉運動方法及注意事項。

(5) 衛教定時排尿的重要性，約每 2-3 小時排尿一次，避免膀胱過漲。

(6) 教導應控制體重勿肥胖，因肥胖易使腹壁肌肉虛弱及腹壓上升。

(7) 避免食用膀胱刺激物，如酒精、咖啡。

2. 社交互動困難／與尿失禁引起羞恥及缺乏自信心有關。

(1) 以主動傾聽、開放式問題、不批判及同理心讓病人說出自己想法並協助個案澄清自我感受。

(2) 多與病人接觸，建立良好治療性人際關係，以取得病人信任。

(3) 告知病人壓力性尿失禁並非不可告人之事，鼓勵與朋友分享自己所面臨到的困擾及感受。

(4) 不斷提供成功案例經驗來喚起個案信心與希望。

(5) 給予病人足夠的時間，鼓勵參加社交活動，協助個案擬定因應方法：如外出時墊護墊增加安全感；與朋友或同事聚會時，多帶幾件內褲及護墊使自己無後顧之憂；選擇深色衣服搭配減少出糞機會。

(6) 安排外出活動時間及排尿時間：每當出門前依自己所需停留做個時間安排，計畫 2-3 小時需解尿。

3. 焦慮感受／與手術前後相關知識不足及不確定感有關

(1) 評估病人焦慮程度及主要原因。

主題名稱	女性壓力性尿失禁	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M09	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	5/10

- (2) 請醫師解釋手術過程協助病人確認可能的壓力來源。
- (3) 向病人解釋開刀前、後的準備工作及注意事項。
- (4) 讓病人瞭解手術後可能存在的管子及其重要性，減少焦慮。
- (5) 常予探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。
- (6) 恐懼感持續無法改善，必要時依醫囑給予鎮靜藥物治療。

4. 疼痛不適／與手術後傷口有關

- (1) 評估病人的疼痛部位、程度（0 不痛～10 最痛）、頻率（間歇、持續）、發作時間、持續時間及特徵（刺痛或拍動痛、深沈或表淺），並記錄疼痛的變化。
- (2) 監測生命徵象的變化，如：疼痛時，血壓上升，心跳、呼吸次數增加。
- (3) 與病人或家屬確認引發疼痛的因素，如個人的、與疾病有關的、與治療有關的。
- (4) 與病人或家屬共同討論減少或排除疼痛的方法。
- (5) 評估病人使用疼痛控制方法的意願，在病人選擇疼痛控制方法時，如止痛劑、止痛藥、自控式止痛等，應給予教導與支持。
- (6) 教導病人疼痛時，採取舒適的臥位，如側臥、半坐臥、軀體彎曲位或端坐臥式。
- (7) 鼓勵病人運用熱敷、按摩背部及休息來緩解疼痛的不適感。
- (8) 教導病人放鬆技巧或轉移注意力，如漸進式肌肉放鬆法、按摩、聽音樂、看電視、散步、閱書、聊天，以減緩疼痛。
- (9) 教導咳嗽或改變姿勢時，以手或束腹帶固定傷口。
- (10) 避免腹部用力，如哭鬧、蹲姿、用力解便、咳嗽，預防傷口疼痛或裂開。
- (11) 多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減緩疼痛。

5. 易感染／與手術後傷口有關。

- (1) 監測生命徵象。
- (2) 監測全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。

主題名稱	女性壓力性尿失禁	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M09	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	6/10

- (3) 記錄及檢查傷口滲出液顏色、氣味、濃稠度、癒合情況。
- (4) 觀察傷口外觀。
- (5) 治療前後洗手。
- (6) 必要時以無菌技術收集標本培養，以監測感染存在。
- (7) 依醫囑正確使用冰或熱敷。
- (8) 依醫囑按時給予抗生素。
- (9) 依醫囑以無菌技術 CD。
- (10) 教導保持傷口乾燥及清潔且避免壓迫傷口並協助、教導翻身方式。
- (11) 教導感染的危險因子及預防感染的重要性方法。

(七) 衛教指導

1. 飲食方面

- (1) 一般而言，手術後視醫囑禁食 8 小時。
- (2) 可以開始進食時，應先喝白開水約 30-50c.c.，若無噁心、嘔吐腹脹、腹痛、腸絞痛後，可吃白飯、新鮮自烹白稀飯、麵條等軟質飲食，勿吃太快太多，避免腸絞痛。沒有任何不適時，可以恢復正常飲食，採少量多餐，不要太油膩及太鹹。
- (3) 建議病人 1 週內少攝取刺激性食物如辣椒、咖啡；少進食易產氣食物如牛奶、蛋、豆類製品、地瓜、麵包等，以防腹脹不適；增加水份攝取及多攝取蔬菜水果等高纖維食物，以避免便秘；建議 2 週內避免進食含人參、麻油、酒等食物，避免影響傷口癒合。

2. 傷口方面

- (1) 每班觀察傷口有無紅、腫、熱、痛，或不正常的分泌物及傷口恢復狀況。
- (2) 教導病人需保持傷口及周圍皮膚清潔與乾燥。

3. 活動方面

- (1) 衛教手術後當天在床上應多翻身或側臥，最好每 2 小時翻身一次，促進血液循環，增加腸蠕動，以預防腸道粘連，視醫囑鼓勵病人下床活動。

主題名稱	女性壓力性尿失禁	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M09	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	7/10

(2)採漸進式下床活動，可以先採半坐臥，若未感不適則可以採坐臥，再坐於床邊，慢慢站起走動，全程需由家屬或朋友陪伴，以防止跌倒之虞。

(3)衛教避免從事會使腹內壓增加之動作如長時間坐或站、勿激烈運動，如機車、騎腳踏車、開車長途旅行、爬山、游泳、勿提重物、大笑等身體用力性動作；以預防便秘；避免長久站立。

(4)衛教應加強骨盆底肌肉群張力及括約肌功能，如操作骨盆底肌肉運動，持續約三至六個星期後，才可能出現效果。

4. 衛生方面

(1)手術後導尿管視醫囑會留置約數天，導尿管留置期間會給予會陰沖洗及導尿管的護理，並視情況協助移除導尿管。視醫囑協助導尿管膀胱訓練，之後再視訓練情形移除導尿管。移除尿管後，需注意第一次解尿時間（4-6 小時內自解）及記錄排尿量與觀察尿液顏色。

(2)手術後若陰道有血狀排泄物，應勤換棉墊，以保持乾淨，避免感染。

(3)每日執行會陰部清潔，清潔時應由會陰部往肛門處（由前往後）清洗，每次如廁後也都要沖洗，衛生紙應由前往後擦拭並保持乾燥，避免感染。

(4)衛教病人身體清潔之照護，如洗澡，建議宜採淋浴方式，勿盆浴及陰道灌洗，應保持傷口處乾燥，以避免傷口感染。

5. 性方面：需在醫師診察傷口癒合後，視情況恢復性生活。

6. 其他方面：

(1)肥胖者需控制體重，減少腹壓。

(2)衛教白天每 2-3 小時及睡前排空膀胱。

(3)教導選擇通氣性佳質料之衣褲。

(4)出院後若有以下情形應立即回診：傷口有紅、腫、熱、痛及滲出液情形；體溫 $>38^{\circ}\text{C}$ 以上；解尿困難、疼痛、頻尿、有灼熱感；陰道出血量多呈鮮紅色、惡臭。

主題名稱	女性壓力性尿失禁	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M09	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	8/10

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲 (2020)。
產科護理學(十版)，新文京。
- (二) 姚毅敏、楊曜蓮、葉惠玲(2022)·一位應力性尿失禁併膀胱脫垂個案之手術全期護理·
領導護理，23(2)，92-103。
- (三) 黃子芸、葉惠玲(2021)·照顧一位婦女應力性尿失禁術後併發急尿感個案之護理經驗·彰化護理，28(4)，133-144。
- (四) Cho, S. T., Kim, K. H. (2021). Pelvic floor muscle exercise and training for coping with urinary incontinence. *Journal of Exercise Rehabilitation*, 17(6), 379-387.
- (五) Jefferson, F. A., & Linder, B. J. (2024). Evaluation and Management of Female Stress Urinary Incontinence. *Mayo Clinic Proceedings*, 99(11), 1802-1814.

七、附件

(略)

主題名稱	女性壓力性尿失禁	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M09	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.02.25	1.0	新制定。	102 年 02 月 25 日護理部照護標準委員會通過；102 年 02 月 25 日公布。
102.08.31	1.1	修正說明(七) 衛教指導內容。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	1.2	更新第六項文獻參考資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	1.3	將參考文獻出處呈現於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.4	第七目之 1(2)內容修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	1.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	1.6	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.07	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	女性壓力性尿失禁	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M09	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
111.11.08	1.7	1. 第三項第一、三、四目說明內容修訂。 2. 第三項第五、六目之護理問題名稱修訂。 3. 第六項參考資料修訂。 4. 刪除內文參考文獻。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	1.8	第三項第四、七目說明內容修訂。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	1.9	第三項第三目之 5.說明內容修訂。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	2.0	1.第三項第六目第 4 點內容修訂。 2.第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。